KIT 9 – REBAIXAMENTO DO NÍVEL DE CONSCIÊNCIA (RNC)

Referências: ABRAMEDE 2024 • AHA/ACLS 2020 • SBCM • Ministério da Saúde • Protocolo Nacional de Emergências Neurológicas

---

Objetivo

Padronizar a solicitação de exames laboratoriais e de imagem nos pacientes com rebaixamento agudo do nível de consciência, garantindo diagnóstico rápido, identificação da causa reversível e abordagem direcionada, com uso racional dos recursos diagnósticos.

---

1. AVALIAÇÃO INICIAL – ABORDAGEM CLÍNICA

- Aplicar **ABCDE da emergência** imediatamente.
- Avaliar **escala de Glasgow** e evolução temporal do rebaixamento.
- Identificar sinais de **focalidade neurológica, convulsões, trauma, hipoglicemia, intoxicação, sepse ou choque.**
- Obter **histórico rápido** (comorbidades, uso de álcool, insulina, anticonvulsivantes, anticoagulantes, psicotrópicos).
- Iniciar **suporte ventilatório e hemodinâmico** conforme necessidade antes da investigação laboratorial.

---

2. EXAMES LABORATORIAIS

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
Glicemia capilar imediata	Todos os pacientes com rebaixamento de consciência.	—
Gasometria arterial / venosa + lactato	Avaliar hipóxia, acidose, retenção de CO_2, choque, intoxicação.	Casos leves de sonolência medicamentosa conhecida.
Hemograma completo	Suspeita de infecção, sepse, anemia aguda.	Sonolência por causa evidente e estável.
Eletrólitos (Na, K, Cl, Ca, Mg)	Suspeita de distúrbios metabólicos, convulsões, arritmias, IC.	Casos com causa neurológica clara (ex: AVC confirmado).
Ureia / Creatinina / Osmolaridade sérica	Avaliar função renal, encefalopatia urêmica, intoxicações, desidratação.	Casos agudos por trauma isolado sem disfunção renal.

Exame	Indicação de Solicitação	Evitar / Não Indicado
TGO / TGP / Bilirrubinas	Suspeita de encefalopatia hepática, hepatite, insuficiência hepática.	Casos não compatíveis com doença hepática.
Glicemia sérica / Cetonemia / Cetonúria	Suspeita de cetoacidose diabética, hipoglicemia prolongada.	Sem sinais de distúrbio metabólico.
Troponina / CK-MB	Pacientes idosos, hipotensos, com taquiarritmias ou choque.	Casos metabólicos ou tóxicos isolados.
PCR / Procalcitonina	Suspeita de sepse, meningite, infecção sistêmica.	Casos tóxicos ou neurológicos puros.
Beta-hCG	Toda mulher em idade fértil.	—

3. EXAMES DE IMAGEM

a) Primeira linha (emergencial / até 20 min)

Exame	Indicação	Evitar / Não Indicado
TC de Crânio sem contraste	Todo paciente com rebaixamento de consciência de causa não identificada, trauma craniano, sinais focais, uso de anticoagulante, suspeita de HSA ou AVC.	Casos metabólicos ou tóxicos com diagnóstico clínico evidente.
RX de Tórax (PA/AP)	Suspeita de pneumonia, sepse, aspiração, congestão pulmonar.	Casos puramente neurológicos sem sintomas respiratórios.
ECG de 12 derivações	Avaliar arritmias, isquemia, distúrbios eletrolíticos.	—

b) Segunda linha (dirigida à hipótese)

Exame	Indicação (Solicitar se)	Evitar / Não Indicado
TC de abdome / pelve	Suspeita de foco infeccioso abdominal, sangramento interno, intoxicação com dor abdominal intensa.	Casos neurológicos isolados.
TC de tórax com contraste (Angio-TC)	Suspeita de TEP em paciente com hipoxemia e rebaixamento inexplicado.	Casos com causa metabólica definida.
EEG (Eletroencefalograma)	Suspeita de estado de mal não convulsivo, causas anóxicas ou metabólicas.	Casos já reativos e com melhora clínica rápida.
Punção lombar (PL)	Suspeita de meningite, encefalite, HSA com TC normal.	Instabilidade hemodinâmica,

Exame	Indicação (Solicitar se)	Evitar / Não Indicado
		hipertensão intracraniana, coagulopatia.

4. PRINCIPAIS ETIOLOGIAS E EXAMES CORRESPONDENTES

Causa Suspeita	Exames Principais	Exame de Imagem Indicada
Hipoglicemia	Glicemia capilar, glicemia sérica	—
Hipóxia / Hipercapnia	Gasometria arterial, lactato	RX Tórax ± TC de tórax
AVC / HSA / Trauma craniano	Hemograma, eletrólitos, glicemia	TC de crânio sem contraste
Sepse / Infecção do SNC	Hemograma, PCR, culturas, função renal	RX Tórax ± TC crânio ± PL
Cetoacidose / Encefalopatia metabólica	Gasometria, cetonemia, função renal/hepática	—
Intoxicação / Overdose	Toxicológico, eletrólitos, ECG	TC crânio ± RX tórax
Coma hepático / urêmico	Função hepática, amônia, função renal	USG abdome total
Coma mixedematoso / Addisoniano	TSH/T4L, cortisol	—

5. PRIORIDADES

- **Afastar causas reversíveis primeiro:** hipoglicemia, hipóxia, hipotensão, hipotermia.
- **Garantir via aérea e oxigenação antes dos exames.**
- **Evitar atrasar a TC de crânio** em casos de rebaixamento inexplicado.
- Solicitar **laboratoriais básicos iniciais** (hemograma, gasometria, eletrólitos, função renal/hepática).
- Em **pacientes com Glasgow ≤ 8**, iniciar **IOT e suporte avançado de vias aéreas**.
- Repetir **gasometria e glicemia** conforme resposta terapêutica.

Resumo Prático:

Cenário Clínico	Exames Laboratoriais	Exames de Imagem
RNC súbito sem causa aparente	Glicemia, gasometria, eletrólitos, função renal, TGO/TGP, PCR	TC crânio ± RX tórax

Cenário Clínico	Exames Laboratoriais	Exames de Imagem
RNC com trauma	Hemograma, coagulograma, função renal, eletrólitos	TC crânio sem contraste
RNC séptico / infeccioso	Hemograma, PCR, culturas, gasometria, lactato	RX tórax ± TC crânio
RNC metabólico (CAD, hepático, urêmico)	Gasometria, glicemia, função renal/hepática, cetonas	—
RNC tóxico / overdose	Toxicológico, eletrólitos, ECG	TC crânio ± RX tórax

Conclusão

A abordagem do rebaixamento de consciência deve priorizar **causas reversíveis e de tratamento imediato**, associando avaliação neurológica rápida com exames laboratoriais dirigidos. A **TC de crânio sem contraste** continua sendo o exame de imagem prioritário, e a **glicemia capilar** deve ser sempre o primeiro passo diagnóstico.

- ✅ Diagnóstico rápido e seguro
- ✅ Correção imediata de causas reversíveis
- ✅ Redução de solicitações desnecessárias
- ✅ Melhoria do tempo de resposta clínica